

Olvido y Trastornos de la Memoria

Concepto de Olvido

"Olvido" = no recordar → proceso temporal + normal.

Explicación

El olvido cotidiano no es una patología ni un defecto cerebral. Constituye un mecanismo psicológico normal, temporal y necesario que impide la saturación de información irrelevante en la mente.

Causas del Olvido

"Causas del olvido" ⊃ decaimiento + interferencia.

Explicación

El fenómeno del olvido se origina principalmente por tres vías fundamentales: el decaimiento gradual de la huella, el bloqueo por interferencia entre datos y la falla de recuperación.

"Decaimiento de la huella" = paso del tiempo + desuso.

Explicación

Esta causa postula que las huellas de memoria dejadas en el sistema nervioso se desvanecen gradualmente si no reciben un repaso o uso continuo conforme avanza el tiempo.

"Curva del olvido" de Ebbinghaus → mayor tiempo ↓ información.

Explicación

El modelo gráfico de Hermann Ebbinghaus demuestra que la pérdida de los datos aprendidos es sumamente acelerada al inicio y se desacelera después, reduciendo la retención.

"Interferencia" = recuerdos obstruyen almacenamiento o recuperación.

Explicación

La interferencia ocurre cuando los contenidos almacenados compiten entre sí. Esto genera un bloqueo que impide fijar nuevos aprendizajes o rescatar los datos antiguos.

"Interferencia retroactiva" = información nueva X recuerdo previo.

Explicación

Este tipo de interferencia opera hacia atrás en el tiempo, donde un aprendizaje actual entorpece, enmascara o destruye temporalmente la retención de un conocimiento adquirido antes.

"Interferencia proactiva" = recuerdo previo X información nueva.

Explicación

La interferencia proactiva actúa hacia adelante, implicando que un hábito o dato antiguo y sólidamente consolidado obstaculiza de forma directa la asimilación de nueva información.

"Falla de reproducción" = dato inaccesible → "punta de la lengua".

Explicación

Se presenta cuando la información continúa grabada en la memoria pero no puede ser localizada ni expresada en el momento preciso, generando la clásica sensación de estar en la punta de la lengua.

Amnesia

"Amnesia" = no recordar → permanente + patología cuantitativa.

Explicación

La amnesia constituye un trastorno grave y patológico de la memoria. Se clasifica como cuantitativa debido a que implica una pérdida real y duradera de los recuerdos.

"Causas de amnesia" ⊃ orgánicas + funcionales.

Explicación

Los factores que desencadenan la amnesia se dividen en orgánicos, asociados a daños físicos directos en el tejido cerebral, y funcionales, vinculados a traumas de tipo psicológico.

"Amnesia retrógrada" = accidente → olvida pasado.

Explicación

Esta variante de amnesia inhabilita al sujeto para rescatar los acontecimientos y vivencias que ocurrieron cronológicamente antes de que se produjera el traumatismo o lesión.

"Amnesia anterógrada" = accidente → olvida nuevo.

Explicación

En la amnesia anterógrada se conservan los recuerdos antiguos, pero el cerebro pierde por completo la facultad biológica de registrar, codificar y consolidar nuevos datos tras el evento.

Paramnesia

"Paramnesia" = falla cualitativa → falso reconocimiento.

Explicación

A diferencia de la amnesia cuantitativa, la paramnesia representa una alteración cualitativa de la memoria donde el contenido no se pierde, sino que se distorsiona al experimentarse falsamente.

"Déjà vu" = experiencia nueva → sentido de familiaridad.

Explicación

El fenómeno de lo ya visto consiste en una ilusión de la memoria donde una vivencia o escenario totalmente inédito se percibe con una absoluta y confusa sensación de familiaridad.

"Jamais vu" = experiencia conocida → se percibe extraña.

Explicación

El fenómeno de lo nunca visto actúa de forma contraria al déjà vu, provocando que un lugar o situación plenamente conocida se sienta de pronto como algo completamente ajeno.

Enfermedad de Alzheimer

"Alzheimer" = enfermedad neurodegenerativa ⊃ demencia.

Explicación

El Alzheimer es una patología de carácter degenerativo, progresivo e irreversible que constituye la manifestación clínica más frecuente de los diferentes tipos de demencia senil.

"Causas de Alzheimer" $\supset \downarrow$ acetilcolina + proteína tau.

Explicación

En el plano fisiopatológico, la enfermedad se origina por una fuerte disminución del neurotransmisor acetilcolina y la alteración destructiva de la neurona mediante la acumulación de proteína tau.

"Síntomas iniciales" de Alzheimer $\supset \downarrow$ MCP + desorientación.

Explicación

Las primeras manifestaciones clínicas comprometen de forma directa el funcionamiento de la memoria a corto plazo, apareciendo además severos episodios recurrentes de desorientación espacial y temporal.